



# ჯანდაცვის ორგანიზაციების ხარისხის მართვის პრობლემისათვის საბაზრო პირობებში

**რეზიუმე**

სტატიაში ავტორი განიხილავს ჯანდაცვის ორგანიზაციების ხარისხის მართვის პრობლემებს საბაზრო პირობებში და აღნიშნავს, რომ სამედიცინო ორგანიზაციების საქმიანობა საბაზრო პირობებში ძირეულად არის შეცვლილი. ავტორის აზრით, ჯანდაცვის ორგანიზაციებმა აითვისა გარემოსთან ურთიერთქმედების ახალი ფორმები, ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაზარი უბრალოდ უმტკივნეულოდ „მოიცილებს“ მათ, როგორც არაკონკურენტუნარიან სუბიექტებს.

ავტორი თვლის, რომ სამედიცინო ორგანიზაციები სწორედ ამიტომ არ იყენებენ მართვის არაეფექტურ მოდელებსა და მეთოდებს. კონკურენტუნარიანობის მაღალი დონის შენარჩუნებისთვის კი მათ ინსტრუმენტს მენეჯმენტის საიმედო სისტემა წარმოადგენს, რომელიც უზრუნველყოფს ეფექტიანობის, მიზანმიმართულობისა და ერთიანობის მდგრად ზრდას.

**საკვანძო სიტყვები:** ხარისხის მენეჯმენტი, ჯანდაცვის ორგანიზაციები, სისტემები.

სამედიცინო ორგანიზაციების საქმიანობა საბაზრო პირობებში ძირეულად არის შეცვლილი. მათ აითვისეს გარემოსთან ურთიერთქმედების ახალი ფორმები, ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაზარი უბრალოდ უმტკივნეულოდ „მოიცილებს“ მათ, როგორც არაკონკურენტუნარიან სუბიექტებს. სწორედ ამიტომ, სამედიცინო ორგანიზაციები არ იყენებენ მართვის არაეფექტურ მოდელებსა და მეთოდებს. კონკურენტუნარიანობის მაღალი დონის შენარჩუნებისთვის კი სამედიცინო ორგანიზაცია იყენებს მენეჯმენტის (ანუ მმართველი და სამართავი კომპონენტების) საიმედო სისტემას რომელიც უზრუნველყოფს ეფექტიანობის, მიზანმიმართულობისა და ერთიანობის მდგრად ზრდას (სურათი 1).

**რუსუდან ქუთათელაძე**

**ეკონომიკის დოქტორი,**

**სტუ-ს პროფესორი**

**მარიამ კვირიკაშვილი**

**სტუ-ს დოქტორანტი**

**E-mail: mariamkvirikashvili770@gmail.com**

ინოვაციური განვითარების მნიშვნელოვან და ეფექტიან მექანიზმს პროექტების მენეჯმენტი წარმოადგენს, რომელიც სტრუქტურულ (სარესურსო უზრუნველყოფა: მატერიალური, შრომითი, ფინანსური, ინფორმაციული, სხვა) და შინაარსობრივ (ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) კომპონენტებს მოიცავს. გარდა ამისა, საპროექტო მენეჯმენტი შეიცავს რაციონალური დაგეგმვისა და რესურსების ეფექტიანად გამოყენების კომპონენტებსაც. ამდენად, საბაზრო პირობებში სამედიცინო ორგანიზაციები საბიუჯეტო სახსრების მომხმარებელიდან გარდაიქმნება დამოუკიდებელ მეწარმე სუბიექტებად, რომელთათვისაც საბაზრო პრიორიტეტები უმთავრესი ხდება.

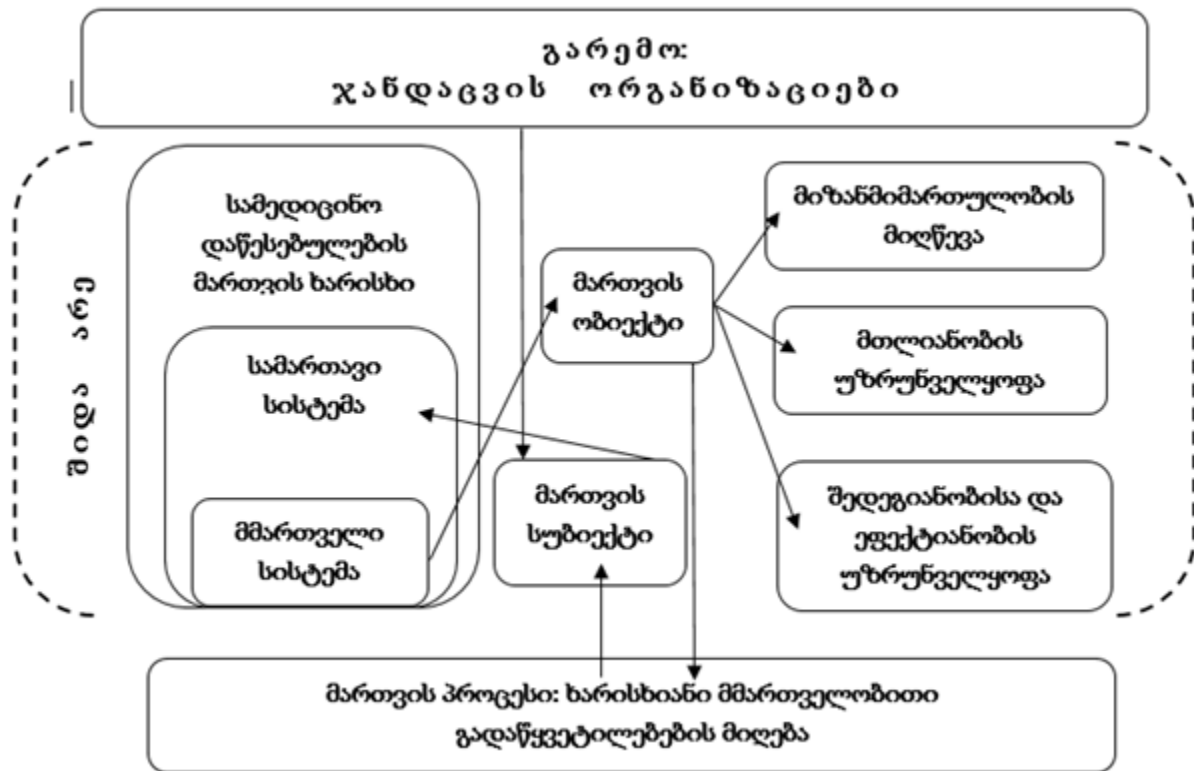
დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროსათვის უმთავრესია კადრების მომზადების, ანუ ადამიანური რესურსების კვალიფიკაციის პრობლემა. გარდა ამისა, პრობლემად რჩება პირველადი დახმარების აღმოჩენი დაბალი რანგის სამედიცინო პერსონალის მომზადების დონე, მათი მსხვილ ქალაქებში კონცენტრაცია, ექიმებისა და საშუალო სამედიცინო პერსონალის რაოდენობრივი დისბალანსი, არასაკმარისი სოციალური დაცულობა, სამეცნიერო კვლევების დაბალი კონკურენტუნარიანობა, ინოვაციური მიღწევების დაბალი მაჩვენებელი.

აქედან გამომდინარე, სამედიცინო ორგანიზაციის მართვის სიტემას უნდა ახასიათებდეს ორგანიზაციული მოქნილობა და თვითრეგულირების თვისება, რომლებიც აძლევს მას გარემო პირობებზე, ანუ ბაზარებისა და ტექნოლოგიების ცვლილებაზე მორგების საშუალებას.

პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ დამოუკიდებლობის პირობებში საქართველომ ვერ მიაღწია ორგანიზაციების მასშტაბურობას, ფინანსური სიმძლევრების დაგროვებას, რაც მისთვის უნდა



სურათი 1. ჯანდაცვის ორგანიზაციების ძირითადი და მაფორმირებელი ურთიერთდამოკიდებულებები კატეგორიისათვის „ხარისხის მართვა“



გამხდარიყო შემდგომი წარმატების გარანტი. ამიტომაც შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ჯანდაცვის სფეროს მენეჯმენტს ჯერ კიდევ მისაღწევია აქვს სტრუქტურებისა და ფორმების სრულყოფილების დონე. მან უნდა გაზარდოს საქმიანობის ეფექტიანობა ერთობლივი პრინციპების, მეთოდების, ტექნიკური საშუალებებისა და მართვის ტექნოლოგიების გამოყენების გზით. ამასთან ერთად, მან უნდა შეინარჩუნოს ორგანიზაციის ერთიანობა, და იზრუნოს მართვის ხარისხი, რათა დააკმაყოფილოს მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვის სფეროსადმი არსებული მოთხოვნები.

მმართველობითი სისტემის ძირითად მასტიმულირებელ ფაქტორს წარმოადგენს სამედიცინო ორგანიზაციების მართვის სისტემის სუბიექტების ხარისხობრივი ზემოქმედება მართვის ობიექტებზე (კოლექტივები, ცალკეული მუშაკები) მართვის პროცესში, რომლის დროსაც მიიღება გადაწყვეტილებები ჯანდაცვის ორგანიზაციის საბოლოო მიზნის მიღწევის გზების შესახებ.

სამედიცინო ორგანიზაციის ობიექტების, როგორც ერთიანი მმართველობითი სისტემის მეცნიერულ გაცნობიერებასთან ერთად, იგი ამგვარადვე შეიმუშავება და დროთა განმავლო-

ბაში ინარჩუნებს მართვის სუბიექტებსა და ობიექტებს შორის ამგვარ ურთიერთდამოკიდებულებას. ამიტომაც მმართველობითი სისტემის ერთიანობისა და ორგანიზებულობის შენარჩუნება ხორციელდება მის ქვესისტემებზე ხარისხობრივი ზემოქმედების გზით, რომლის პროცესშიც გამოიყენება „ხარისხობრივი დამოკიდებულების“ არსებითი თვისებები. ასეთი რთული პროცესის განმავლობაში მმართველი მენეჯერები მუდმივად უნდა ახდენდნენ საკუთარი ცოდნის, ინტელექტისა და ტექნოლოგიების სრულყოფასა და მათ პრაქტიკაში გამოყენებას. რაც უფრო აქტიური და პროფესიონალურია მმართველი სისტემების ორგანიზაციული ზემოქმედება სამართავზე, მით მაღალია სისტემის მართვადობის ხარისხი.

ამ პროცესში ტექნოლოგიები მოიცავს მენეჯერების ღრმა ცოდნას, პროფესიულ კულტურას და საქმიან აქტიუობას; გარდა ამისა, სამედიცინო ორგანიზაციების სხვადასხვა რანგის მმართველთა პოპულარობასაც. აქედან გამომდინარე, მართვადობის მაორგანიზებელი ტიპი ნიშნავს, რომ მმართველი სისტემა მიისწრაფის მართვადი სისტემის (სამედიცინო ორგანიზაციის) ერთიანობის შენარჩუნებისკენ, რიც გარე-



შეც იგი საბოლოო მიზნის მიღწევის საკუთარ შესაძლებლობებში იხილება.

ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონცეფციის შესაბამისად, არჩევენ ხარისხის სამ ასპექტს:

- სტრუქტურის (მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა) ხარისხს,
- პროცესის (სამედიცინო დახმარება) ხარისხს,

• შედეგების (სამედიცინო დახმარების შედეგებისა და ინფრასტრუქტურის საექსპერტო შეფასებები) ხარისხს.

ამდენად, სამედიცინო ორგანიზაციაში ხარისხობრივად ახალი ურთიერთობების ფორმირების გზები და მექანიზმები, რომლებიც ხელს უწყობს საბაზრო პირობებში მოქმედ ჯანდაცვის სისტემაში მენეჯმენტის პოტენციალის აქტივიზაციას, მოიცავს შემდეგ დებულებებსა და მიმართულებებს:

- ჯანდაცვის სფეროში ეკონომიკური ურთიერთობების ფორმირება და ჯანდაცვის მენეჯერების, როგორც ახალი საკადრო რესურსის პრიორიტეტული გამოყენება;
- მართვის მოდელირებისა და ორგანიზების ახალ მეთოდებზე გადასვლა, ანუ ჯანდაცვის სისტემაში სიტუაციურ-იმიტაციური მოდელირების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება მეცნიერულად დასაბუთებული კლასიკური მეთოდების შესავსებად და გასამდიდრებლად;
- ჯანდაცვაში ინტერაქტიული ინოვაცი-

ური მენეჯმენტის გამოყენება, რომელსაც მუდმივი გაურკვევლობის პირობებში შეუძლია სტრატეგიის შემუშავება, ეყრდნობა რა ტოპ-მენეჯმენტის შემოქმედებით პოტენციალსა და მაქსიმალურად არის ჩართული სამომავლო პროექტების, პროგნოზებისა და პროგრამების ფორმირებაში და ხორციელდება სხვადასხვა სფეროში დაგროვილი ჰუმანიტარული ცოდნის გამოყენებით;

• გარემოს ტურბულენტობის (დაუგეგმავი სწრაფი ცვლილებების) პირობებში საკუთარი საქმიანობის კორექტირებისათვის საუკეთესო შესაძლებლობების გამოთხზვა;

• ხარისხიანი მმართველობითი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების კომპლექსის შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს სამედიცინო ორგანიზაციებისა და ჯანდაცვის სფეროს გრძელვადიან და ეტაპობრივ განვითარებას;

• დიაგნოსტიკური, სამკურნალო, სარეაბილიტაციო და ჯანდაცვის სფეროს მართვის სხვა ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება;

• სამედიცინო ორგანიზაციების სტრუქტურისა და მისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ცვლილება.

დასასრულ აღვნიშნავთ, რომ ჯანდაცვის სამართავ სფეროში პრიორიტეტული გადაწყვეტილებების რეალიზებამ უნდა განაპირობოს და განამტკიცოს კონსტრუქტიული მენეჯმენტის სტრატეგიული პრინციპები და ახალი ტექნოლოგიები.

#### გამოყენებული ლიტერატურა:

1. შ 8000: 2001. სოციალური და ეთიკური მენეჯმენტის სისტემა [ელექტრონული რესურსი]. – ხელმისაწვდომია: <http://www.polymerbranch.com/docs/view/99.html>.
2. The ISO Survey of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates. – 2002. – December. – 189 p. The EFQM Excellence Model [elektronuli resursi]. [www.efqm.org](http://www.efqm.org).
3. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით N 537 „2020 წლამდე საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის შესახებ“, 2017 წლის 12 მაისი;
4. Glossary of terms used in the management of quality; 6th ed. – European Organization for Quality, 1989. – 21 p.
5. ე. ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე, ა. აბრალავა, „მენეჯმენტი და ადმინისტრირება“, თბილისი, 2007, 715გვ.
6. ბარათაშვილი ე., ქოქიაური ლ., „მენეჯ-

მენტის პრინციპები“, თბილისი, 2010, გვ. 707.

7. გარეთ რ. ჯონსი, ჯენიფერ მ. ჯორჯი „თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები.“ თბილისი, 2006. თარგმანი ინგლისურიდან. გვ. 350.

8. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, მე-12-ე ტომი, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2015, გვ. 391

9. „მენეჯერის ბრძოლა წარმატებისათვის“, ჟ. სტრატეგია და ორგანიზაციები, საუკეთესო სტატიების კრებული, თბილისი, 2012, გვ. 205.

10. ნ. ბაკაშვილი, დ. მესხიშვილი, ლ. ქადაგიშვილი, „ორგანიზაციის თეორია“, თბილისი, 2009

11. Evans J. R. The management and control of quality / J. R. Evans. – Cincinnati, Ohio South Western College Publishing, 2009. – 225 p.

12. Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? / A. Donabedian; Oper. & Prod. Manag. – 2011. – Vol. 2, N 12. – P. 516.



## QUALITY MANAGEMENT OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS IN THE MARKET CONDITIONS

**RUSUDAN KUTATELADZE**  
*Docotor of Economics,*  
*Professor of GTU*

**MARIAM KVIRIKASHVILI**  
*The Doctoral Student of GTU*  
*E-mail: mariamkvirikashvili770@gmail.com*

### Summary

In the article the author discusses the quality of healthcare management problems in market conditions and notes that the activities of medical organizations are substantially changed in the market conditions. In the opinion of the author, the health organizations have mastered the new forms of interaction with the environment, because otherwise the market will simply “eliminate” them as non-competitive subjects.

The author believes that medical organizations do not use ineffective models and methods of management. To maintain a high level of competitiveness, their instrument provides a reliable system of management that ensures sustainable growth of efficiency, purposefulness and unity.

**Keywords:** Quality management, health care organizations, systems.